

Dlaczego *unikanie utrwała*

Paradoks PTSD: to, co najbardziej pomaga krótkoterminowo, najbardziej szkodzi długoterminowo. Model błędnego koła wyjaśnia, dlaczego unikanie zamiast leczyć — utrwała objawy na lata.

CZAS: 15 min — przeczytanie Przed rozpoczęciem ekspozycji

ŹRÓDŁO: Foa & Kozak (1986); Ehlers & Clark (2000)

JAK UŻYWAĆ

Po traumie pojawia się **logiczna reakcja**: unikać wszystkiego, co przypomina o zdarzeniu. Miejsc, ludzi, myśli, rozmów, sytuacji. Krótkoterminowo to **działa** — lęk natychmiast spada. Ale długoterminowo wytwarza się **błędne koło**: unikanie → krótkotrwała ulga → wzmocnienie sygnału „to było naprawdę niebezpieczne” → silniejszy lęk następnym razem → więcej unikania. Z każdym cyklem mapa zagrożenia się rozszerza. Po latach to, co było pojedynczą sytuacją, staje się siatką unikanego życia.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Foa i Kozak (1986) opisali to w modelu **struktur lęku**: trauma tworzy w pamięci sieć skojarzeń (bodziec → znaczenie → reakcja), która jest *nieprawdziwa w obecnej rzeczywistości* ale prawdziwa w pamięci ciała. Aby się rozluźniła, musi otrzymać **nowe doświadczenie**: „byłem w tej sytuacji, nic się nie stało, lęk minął sam”. Unikanie blokuje to nowe doświadczenie. Ehlers i Clark (2000) dodali, że PTSD wynika z **poczucia stałego zagrożenia**, podtrzymywanego przez strategie radzenia sobie, w tym unikanie. **Praktyczna konsekwencja**: wyleczenie wymaga zrobienia tego, co wydaje się najtrudniejsze — kontrolowanego kontaktu z tym, czego unikasz. Nie chodzi o „odważne stawanie naprzeciw” — chodzi o *stopniowe, planowe* rozmontowanie błędnego koła.

01 → Błędne koło unikania — sześć ogniw

1 · WYZWALACZ

Pojawia się bodziec kojarzący się z traumą (zapach, dźwięk, sytuacja). Ciało migdałowe rozpoznaje wzorzec → alarm.

2 · LĘK I OBJAWY SOMATYCZNE

Tętno wzrasta, oddech przyspiesza, myśli — „zaraz coś się stanie”, „to jest niebezpieczne”.

3 · UNIKANIE / UCIECZKA

Wycofujesz się fizycznie albo myślowo (rozproszenie uwagi, dysocjacja, alkohol, telefon). Bodziec znika.

4 · NATYCHMIASTOWA ULGA

Lęk gwałtownie spada. Mózg uczy się: „unikanie zadziałało”. To wzmocnienie negatywne (skuteczna ucieczka od bólu).

5 · WZMOCNIENIE SKOJARZENIA

Pamięć zapisuje: „ten bodziec naprawdę był niebezpieczny — gdybym tam został/-a, byłoby źle”. Skojarzenie zagrożenia staje się silniejsze.

6 · MAPA UNIKANIA ROZSZERZA SIĘ

Następnym razem reagujesz silniej i unikasz wcześniej. Lista „niebezpiecznych” sytuacji rośnie. Życie się zwęża.

02 📖 Cztery rodzaje unikania — sprawdź, które robisz

1 · BEHAWIORALNE — SYTUACJI

Unikam miejsc, ludzi, aktywności kojarzących się z traumą. Wybieram dłuższą trasę. Odmawiam zaproszeń. Nie wchodzę do windy / samochodu / supermarketu.

2 · POZNAWCZE — MYŚLI

Odsuwam myśli o tym, co się stało. Zmieniam temat, gdy ktoś pyta. Tłumię wspomnienia. „Nie chcę o tym myśleć” — i utrwalam.

3 · EMOCJONALNE — UCZUĆ

Wycinam dostęp do uczuć (smutku, lęku, gniewu). Odrętwienie. Anhedonia. Brak płaczu, brak radości. „Po prostu nic nie czuję.”

4 · SUBSTANCJONALNE — CHEMIA

Alkohol, leki uspokajające, narkotyki, kompulsywne zachowania (jedzenie, hazard, telefon) — wszystko, co tymczasowo wyłącza odczucia.

03 ☉ Jak przerwać błędne koło — mechanizm ekspozycji

Ekspozycja działa, bo *uczy mózg nowego doświadczenia*: bodziec → lęk → **nic złego się nie stało** → lęk samoistnie opada. Z czasem mózg zapisuje nowe skojarzenie: ten bodziec jest bezpieczny.

1 • STOPNIOWANIE

Zaczynasz od najłagodniejszych wyzwalaczy (SUDS 2–3), nie od najgorszych. Hierarchia daje stopniowe poszerzanie okna tolerancji.

2 • POZOSTANIE DO SPADKU LĘKU

Lęk *samoistnie* opada w ciągu 20–45 minut, jeśli pozostaniesz. To biologiczna habituacja. Wyjście wcześniej anuluje proces uczenia.

3 • POWTARZANIE

Pojedyncze doświadczenie nie wystarczy. Powtarzanie 3–5 razy w tygodniu przez 2–4 tygodnie tworzy nowe, silne skojarzenie. To „przepisanie” pamięci.

4 • BEZ ZACHOWAŃ KOMPENSACYJNYCH

Podczas ekspozycji *nie* używasz alkoholu, leków doraźnych, intensywnego rozpraszania uwagi. Mózg potrzebuje pełnego doświadczenia, że *sam* sobie poradził.

04 Krótki vs długoterminowy efekt — wybór

UNIKANIE

Krótko: natychmiastowa ulga, lęk spada w sekundach.

Długo: mapa unikania rośnie. Życie się zwęża. PTSD utrwała się latami. Anhedonia, izolacja, depresja jako dodatek.

STOPNIOWA EKSPOZYCJA

Krótko: trudno. Lęk wzrasta przed spadkiem. Wymaga obecności terapeuty i wsparcia.

Długo: mapa unikania kurczy się. Życie wraca. Objawy PTSD spadają mierzalnie (CAPS, PCL-5).

Klucz: w długoterminowym badaniu Foa i wsp. (2005) pacjenci z PTSD *pozostający w unikaniu* mieli po 5 latach takie same lub silniejsze objawy. Pacjenci po pełnym kursie ekspozycji (PE) mieli **60–80% redukcji objawów** i stabilność tej poprawy po latach. Ekspozycja nie znaczy „rzucenie się na głęboką wodę” — to *planowane, stopniowe, wspierane przez terapeutę* rozmontowanie błędnego koła. Bez tego unikanie kontynuuje swój proces. Cisza i unikanie nie są neutralne — są aktywnym utrwalaniem PTSD.